

Дата: 21.01.2025

Полис ОМС: 2988299720000033

Медицинское учреждение : Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы"

Специализация: Врач-рентгенолог

ФИО: Шмелева Дарья Валерьевна

Магнитно-резонансная томография коленного сустава

Информация об исследовании	Предварительный диагноз: не указано Цель исследования: не указано Обоснование: не указано Дата исследования: 21 января 2025, 18:06
Тип чтения	Первое чтение.
Базовое исследование для сравнения	Дата проведения: 20.01.2025.
Место проведения расшифровки исследования	ГБУЗ "НИИ НДХиТ ДЗМ".

Описание	На сериях МР томограмм левого коленного сустава, полученных в 3-х плоскостях, в положении сканирования взаимоотношения в коленном суставе не нарушены, суставные поверхности в целом конгруэнтны. Зоны роста с тенденцией к закрытию. Визуализируется протяженная зона трабекулярного отека передне-наружных отделов латерального мыщелка бедренной кости. В проекции наиболее выраженного отека определяется зона импрессионной деформации кортикального слоя передне-боковой поверхности мыщелка. Гиалиновый хрящ остальных отделов суставной поверхности мыщелков бедренной кости и большеберцовой костей не изменен. Форма и положение менисков значимо не изменены, МР сигнал от них не изменен. Задняя и передняя крестообразные связки прослеживаются на всем протяжении, стриарность сохранена. Коллатеральные связки и подвздошно-большеберцовый тракт четко дифференцируются, траектория их не изменена. Перилигаментозно вдоль медиальной коллатеральной связки определяется отек. Подвздошно-большеберцовый тракт четко дифференцируются, траектория их не изменена. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра и собственная связка надколенника не изменены. В положении сканирования индекс Insall-Salvati около 1,4 индекс Caton-Deschamps около 1,35. Индекс ТТ-РСL около 24,0 мм. Угол инклинации латеральной фасетки блока бедренной кости 18 градусов (N>11 градусов). Угол блока бедренной кости 154 градусов (N<145 градусов). Надколенник по форме Wiberg III, обычных размеров, не смещен. Визуализируется импрессионный перелом ниже-медиального края надколенника и остеохондральное повреждение гребня и медиальной фасетки надколенника с формированием свободного хрящевого фрагмента, размерами 11,0 x 9,0 x 5,0 мм у верхних отделов медиальной фасетки надколенника. Хрящ медиальной фасетки и гребня надколенника неоднороден, имеет неровный контур, визуализируются полнослойные его дефекты. Субкортикально в области гребня надколенника определяется дефект костной ткани. Медиальная пателло-фemorальная связка разволокнена, имеет неоднородный МР-сигнал у надколенника и у бедренной кости. Вдоль нее отмечается выпот. Медиальный ретинакулюм отечен, разволокнен в месте прикрепления к надколеннику, в его структуре визуализируется авульсированный фрагмент кортикального слоя ниже-медиальной поверхности надколенника. В препателлярной области отмечается выпот. Траектория волокон латеральной пателло-фemorальной связки прослеживается, сигнал от нее значимо не изменен. Жировые тела деформированы за счет наличия выпота. В основной полости сустава и околосуставных заворотах визуализируется избыточное количество неоднородной жидкости. Синовиальная оболочка реактивно утолщена. Отмечается выпот вдоль хода волокон дистальных отделов широких мышц бедра, с формированием гематомы по внутренней поверхности медиальной широкой мышцы бедра.
Заключение	МРТ картина состояния после острого вывиха надколенника левого коленного сустава: импрессионный перелом передне-наружных отделов латерального мыщелка бедренной кости и ниже-медиального края надколенника; остеохондральное повреждение гребня и медиальный фасетки надколенника с формированием свободного хрящевого фрагмента (на момент исследования: у верхних отделов медиальной фасетки надколенника); признаки полного разрыва медиального ретинакулюма у надколенника с авульсией фрагмента кортикального слоя от ниже-медиальной поверхности надколенника; частичного повреждения медиальной пателло-фemorальной связки у надколенника и у бедренной кости; растяжение медиальной коллатеральной связки, широких мышц бедра; гемартроз; посттравматический синовит. МРТ признаки высокого стояния надколенника; латерализации бугристости большеберцовой кости; дисплазии блока бедренной кости (тип А по Dejour).
Рекомендации	Требуется дообследование: Нет.
Оборудование	Название устройства: МРТ Ingenia Ambition S. Вид: МРТ. Инвентарный номер: 5808. Серийный номер: 5808. Модель: Ingenia Ambition S.